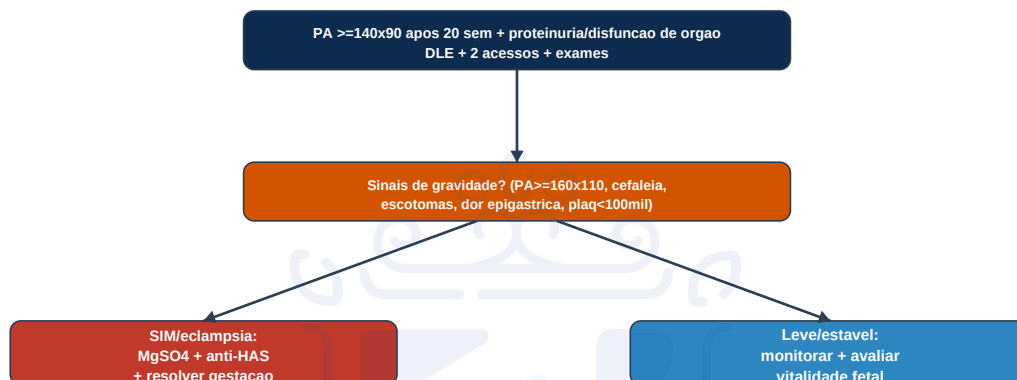


PRÉ-ECLÂMPسيا E ECLÂMPسيا

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA

PRÉ-ECLÂMPسيا — MgSO₄ + CONTROLE DA PA



DEFINIÇÕES

DIAGNÓSTICO

- Pré-eclâmpsia: PA $\geq$ 140x90 após 20 semanas + proteinúria $\geq$ 300 mg/24h
- OU, sem proteinúria: plaquetas $<$ 100.000, creatinina $\geq$ 1,1, TGO/TGP $\geq$ 2x, EAP, sintomas neuro/visuais
- Eclâmpsia: convulsão tônico-clônica em gestante/puérpera sem outra causa neurológica
- O PARTO é o único tratamento DEFINITIVO

PRÉ-ECLÂMPسيا COM SINAIS DE GRAVIDADE

QUALQUER UM = GRAVE

- PA $\geq$ 160 x 110 mmHg
- Cefaleia intensa refratária; escotomas / visão turva (iminência de eclâmpsia)
- Dor epigástrica / em hipocôndrio direito (sofrimento hepático)
- Plaquetas $<$ 100.000; oligúria ($<$ 500 mL/24h)
- Edema agudo de pulmão; disfunção hepática ou renal

ABORDAGEM INICIAL E EXAMES

ABCDE OBSTÉTRICO

- DECÚBITO LATERAL ESQUERDO (evita compressão da cava pelo útero); proteger via aérea
- O₂ 8-10 L/min se SatO₂ $<$ 94%; 2 acessos calibrosos; monitorização; SVD (controle de diurese)
- Avaliar consciência e sinais de iminência de eclâmpsia
- Exames (sem atrasar o tratamento): hemograma, plaquetas, TGO/TGP, creatinina/ureia, DHL (HELLP), proteinúria
- Avaliação fetal: BCF, cardiotocografia se possível

CONTROLE DA CRISE HIPERTENSIVA

Rx META PAS 140-150 / PAD 90-100 (NÃO reduzir abruptamente)

Hidralazina IV: 5 mg IV lento, repetir a cada 20 min (máx 20 mg)
Labetalol IV: 20 mg IV, depois 40-80 mg a cada 10 min (máx 300 mg)
Nifedipina VO: 10 mg VO, repetir após 20 min se necessário
NÃO reduzir a PA de forma abrupta (risco de hipoperfusão placentária)
Contraindicados: IECA/BRA, diuréticos (exceto EAP), metildopa NA EMERGÊNCIA

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CONVULSÃO

Rx SULFATO DE MAGNÉSIO — PADRÃO-OURO

Ataque: 4-6 g IV em 20 min
Manutenção: 1-2 g/h IV contínuo; manter por 24h após o parto ou a última convulsão
Monitorar toxicidade — SUSPENDER se: FR < 12 irpm, ausência de reflexo patelar, diurese < 25 mL/h
Antídoto: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10 mL IV lento
NÃO usar benzodiazepínico como 1a linha (só se convulsão refratária ao magnésio)

ECLÂMPSIA — CONDUTA IMEDIATA

CONVULSÃO NA GESTANTE

- Proteger via aérea + decúbito lateral esquerdo + oxigênio
- Sulfato de magnésio IMEDIATAMENTE (ataque + manutenção)
- Controlar a PA (hidralazina/labetalol/nifedipina)
- Avaliar a vitalidade fetal
- RESOLVER a gestação após estabilização materna

CONDUTA OBSTÉTRICA (RESOLUÇÃO)

QUANDO INTERROMPER A GESTAÇÃO

- SEMPRE: eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave, HELLP, sofrimento fetal, deterioração materna
- Se < 34 semanas e ESTÁVEL: corticoide para maturação pulmonar fetal + avaliação caso a caso
- O parto é o único tratamento definitivo (estabilizar a mãe primeiro)
- Via de parto conforme condições obstétricas
- Complicações: AVC, EAP, HELLP, DPP, insuficiência renal/hepática

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Gestante/puérpera, ____ semanas, com pré-eclâmpsia ____ (com/sem gravidade) / eclâmpsia. PA ____.
- Sinais de gravidade: cefaleia/escotomas/dor epigástrica/plaq<100mil/oligúria. DHL/TGO/creatinina: ____.
- Condutas: MgSO4 (ataque+manutenção), anti-hipertensivo ____, DLE, vitalidade fetal ____.
- Solicito transferência para maternidade de alto risco (resolução da gestação = tratamento definitivo).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Gestante de 32 semanas com PA 170x115, cefaleia intensa e escotomas. Qual a medida para PREVENIR convulsão?

- A) Diazepam endovenoso
- B) Sulfato de magnésio (ataque 4-6 g IV + manutenção 1-2 g/h)
- C) Fenitoína
- D) Manitol
- E) Apenas controlar a pressão arterial

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Durante o uso de sulfato de magnésio, a paciente apresenta FR 10 irpm e ausência de reflexo patelar. Conduta?

- A) Aumentar a dose do magnésio
- B) Suspender o magnésio e administrar gluconato de cálcio 10% IV (antídoto)
- C) Administrar diazepam
- D) Manter a dose e observar
- E) Iniciar hidralazina

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a meta de pressão arterial no tratamento da crise hipertensiva da pré-eclâmpsia grave?

- A) PAS < 110
- B) PAS 140-150 / PAD 90-100, sem redução abrupta
- C) Normalizar rapidamente para 120x80
- D) PAS > 160
- E) PAD < 60

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é o tratamento DEFINITIVO da pré-eclâmpsia/eclâmpsia?

- A) Sulfato de magnésio por tempo indeterminado
- B) Resolução da gestação (parto)
- C) Anti-hipertensivo oral contínuo
- D) Repouso no leito
- E) Diurético

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual anti-hipertensivo é CONTRAINDICADO na gestante com pré-eclâmpsia?

- A) Hidralazina
- B) IECA / BRA
- C) Labetalol
- D) Nifedipina
- E) Metildopa (no seguimento ambulatorial)

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O sulfato de magnésio é o padrão-ouro para prevenir e tratar a convulsão eclâptica (ataque 4-6 g IV + manutenção 1-2 g/h), superior aos anticonvulsivantes clássicos. Benzodiazepínico/fenitoína não são 1ª linha.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

FR < 12 e ausência de reflexo patelar são sinais de toxicidade do magnésio: suspende-se a infusão e administra-se o antídoto, gluconato de cálcio 10% 10 mL IV lento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A meta é PAS 140-150 / PAD 90-100, evitando a redução abrupta da PA, que compromete a perfusão placentária. Usa-se hidralazina, labetalol ou nifedipina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O único tratamento definitivo é a resolução da gestação (parto). MgSO₄ e anti-hipertensivos estabilizam a mãe, mas a doença só regride após o parto.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

IECA/BRA são contraindicados na gestação (fetotoxicidade). Hidralazina, labetalol e nifedipina são as drogas de escolha; metildopa serve para o controle ambulatorial, não para a emergência.

SM24
Suporte ao Plantão Médico